幹部説明原稿 法人経営環境と大橋病院経営戦略

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

幹部説明原稿 ー 法人経営環境と大橋病院経営戦略

説明時間: 約30分
対象会議: 病院運営戦略会議 / 経営会議
作成日: 令和8年4月12日
作成部署: 経営企画

冒頭（2分）

本日は、法人全体の経営環境を踏まえた大橋病院の経営戦略についてご説明いたします。

今回の分析は、令和7年度予算・事業活動収支予算書・資金収支予算書・新中期経営計画・令和6年度貸借対照表・令和7年度上期事業運営状況・令和8年度組織目標・令和7年度事業計画の計8件の法人資料を横断的に分析したものです。

結論から申し上げますと、法人全体は大森再開発を中心とする大型投資の真っ只中にあり、令和7年度は基本金組入前で10.7億円の赤字予算です。この環境下で大橋病院に求められるのは、限られた投資の中での自律的な収益最大化です。大橋病院は3病院中で唯一の粗利益改善を達成しており、法人を支える重要な柱としての役割がますます大きくなっています。

第1部：法人の財務状況（8分）

1. 収支構造の概要

まず法人全体の収支構造です。

令和7年度の事業活動収入は1,013億円、支出は1,024億円で、教育活動収支差額は12.9億円の赤字です。基本金組入前の当年度収支差額は10.7億円の赤字となっています。

ここで重要な点は、収入の増加率が3.3%であるのに対し、支出の増加率は4.6%と、支出が収入を上回るペースで増えている「増収減益」構造にあることです。

特に医療経費は前年比5.3%、15.6億円の増加が見込まれていますが、医療収入の増加は2.0%、15億円にとどまります。高額薬品の使用増や物価高騰が経費を押し上げている状況です。

なお、法人収入の77.6%が医療収入であり、3病院の経営パフォーマンスが法人全体の財務を直接左右する構造です。

2. 中期経営計画（R7-R9）の要点

次に、新中期経営計画の3年間の見通しです。

3年間の第1次収入は3,054億円、第1次支出は2,877億円、粗利益は177億円です。この粗利益は前回中期の実績と比べて15.4%減少しています。

年度別では、令和7年度は10.7億円の赤字ですが、令和8年度に3.5億円、令和9年度に7.7億円の黒字を見込むV字回復型の計画です。3年間の合計はわずか0.48億円の黒字で、ほぼ損益分岐点上にあります。

このV字回復の前提は、医療収入が毎年1.7%から1.9%成長することです。上期実績では医療収入が予算比0.4%の未達であり、計画の実現には全病

院の増収努力が必要です。

3. 設備投資と資金の見通し

設備投資は3年間で306.8億円を計画しています。このうち大森地区再開発が194億円で全体の63%を占めます。習志野新棟が12.4億円、残り100.4億円が3病院と全学の通常設備投資に充てられます。

この投資資金は、手許現預金を3年間で155億円取り崩して賄う計画です。

4. 貸借対照表から見る資産状況

令和6年度末の貸借対照表を確認します。

総資産は1,429億円です。このうち現金預金は259億円、有価証券や信託等を含む金融資産全体では342億円を保有しています。

自己資本比率は68.4%、流動比率は258.8%と、財務基盤自体は健全な状態にあります。借入金は64億円で総資産の4.5%にとどまり、着実に返済が進んでいます。

ただし注意すべき点が3つあります。

1点目、退職給与引当金が238億円と負債の53%を占める最大項目です。教職員の高齢化に伴い今後さらに増加するリスクがあります。

2点目、手許現預金259億円は一見潤沢ですが、中期計画で155億円を取り崩す予定であり、令和7年度末には169億円、令和9年度末には推定88億円にまで減少します。現在の手許資金の約6割を使い切る計算です。

3点目、繰越収支差額は973億円のマイナスで、前年度から40億円悪化しています。これは基本金制度による構造的なものですが、大森再開発の基本金組入により悪化が加速しています。

まとめますと、資産のストックには一定の余裕がありますが、フロー、つまり毎年の収支は赤字であり、手許資金は急速に減少する局面にあるということです。

第2部：大橋病院の戦略的ポジショニング（5分）

1. 3病院比較における大橋の位置づけ

次に、この法人環境の中で大橋病院がどのような位置にいるかを確認します。

上期の3病院比較では、大橋病院は入院単価102,345円で3病院中最高です。大森の92,835円、佐倉の85,360円を大きく上回っています。平均在院日数は8.8日で3病院中最短、救急謝絶率も19.0%で最良です。

さらに重要なのは、4月から2月の累計で粗利益が前年比122.4%の改善を達成し、3病院中で唯一の増益であることです。大森は32.9%減、佐倉は26.4%減と両病院が減益する中で、大橋のみが利益を伸ばしています。

同クラスの急性期一般入院料1算定病院、全国270施設の平均と比べても、入院単価は平均の141%、病床稼働率は11.4ポイント上回っており、320床という規模ながら高い収益効率を実現しています。

2. 法人が大橋病院に求めるもの

この状況を踏まえると、法人が大橋病院に期待するのは3点です。

第一に、自律的な収益改善です。大森再開発に投資が集中する3年間、大橋への追加設備投資は限定的です。既存リソースの最大活用が求められます。

第二に、粗利益の改善継続です。3病院中唯一の増益という実績を維持し、法人全体の黒字転換に貢献することです。

第三に、令和8年度の診療報酬改定効果を確実に取り込むことです。

3. 大橋の課題

一方で課題もあります。

最大の課題は外来患者数の減少です。累計で前年比8.5%減、1日平均852人で予算の910人を58人下回っています。外来単価の上昇で総額は維持していますが、単価だけで量の減少を補い続けるのは限界があります。

また、整形外科の紹介件数が543件減と全科最大の減少を記録しています。これは外来だけでなく入院の上流が枯渇するリスクであり、最優先の対策課題です。

第3部：経営戦略と重点施策（8分）

戦略コンセプト

大橋病院の中期戦略のコンセプトは「限られた投資の中での収益最大化」です。大森再開発に投資が集中するR7からR9の3年間、大規模な設備投資なしに既存リソースを最大活用して収益を伸ばします。

施策1：外来患者数の回復

最も収益インパクトが大きいのが外来患者数の回復です。1日平均58人の減少を予算水準まで回復させると年間約3.2億円の増収が見込まれます。

具体策として、第一に整形外科の紹介回復に集中します。紹介元医療機関への訪問を強化し、減少の原因を個別に分析します。第二にWeb予約システムの活用を促進し、紹介のハードルを下げます。第三に広報を継続強化します。ホームページの閲覧数は前年比約5万件増加しており、この勢いを維持します。

施策2：ダヴィンチ手術の症例拡大

ダヴィンチ手術は現在月平均10.2件で目標を達成しています。令和8年度は外科3術式、泌尿器科2術式の新規届出を計画しており、適応拡大による月3件から5件の追加が見込まれます。年間では1,000万から3,000万円の増収効果です。

手術部門全体でも年間6,336件と前年を174件上回っており、全身麻酔3,261件は急性期充実体制加算の基準2,000件を大幅に超えています。

施策3：診療報酬改定効果の最大化

令和8年度の診療報酬改定への対応では、施設基準の総点検と早期届出を最優先で行います。DPC機能評価係数の最大化、算定漏れの防止に注力し、施設基準管理システムの導入も進めます。大森病院が先行導入しているシステムを大橋にも展開します。

施策4：医療経費の抑制

医療経費の抑制は、3病院共同の取り組みを最大限活用します。薬剤部長会議での共同購買、用度課実務担当者会議でのベンチマークに基づく価格

交渉を通じ、1%の削減で年間5,000万から5,500万円の改善が見込まれます。

施策の収益インパクトまとめ

4つの施策を合わせると、診療報酬改定効果を除いても年間1.6億から4.5億円の収益改善が見込まれます。法人の中期計画がR8に3.5億円、R9に7.7億円の黒字を想定していることを踏まえると、大橋病院の貢献は法人全体の黒字転換にとって不可欠な規模です。

第4部：インセンティブ制度の提案（7分）

1. 背景と設計思想

続いて、経営改善と連動したインセンティブ制度についてご説明します。

大橋病院の人件費率は41.2%で、同クラス平均の51.7%を10.5ポイント下回っています。これは効率的な経営の証ですが、裏を返せば職員の処遇に改善余地があることも示唆しています。

恒久的なベースアップは、現在の粗利益率0.8%では赤字転落のリスクがあり、法人の中期計画が人件費の抑制を前提としていることからも困難です。

そこで提案するのは、業績連動型のインセンティブ制度です。増収に連動して支給するため、収益が上がれば職員に還元、上がらなければ自動調整される仕組みです。法人の計画と矛盾せず、職員のモチベーション向上と増収の好循環を生み出します。

2. 二層構造の設計

制度は二層構造です。

第1層はKPI連動型で、ダヴィンチの手術件数、救急入院率、紹介件数回復、算定漏れ防止、病床稼働率の5項目です。対象は各部門のチームで、年間最大1,680万円です。これらのKPIを達成すると、増収効果でインセンティブ原資を自己回収できる設計になっています。

第2層は人事評価連動型で、全職員が対象です。ただし基準を高く設定し、メリハリをつけます。

評価はS、A、B+、B、Cの5段階で、インセンティブが付くのはB+以上です。

Sランクは全体の5%、約35名で、部門目標を大幅超過し組織全体に波及効果をもたらした方です。院長承認制とし、安易な乱発を防ぎます。

Aランクは15%、約105名で、目標を超過達成し改善提案を実行に移した方です。

B+ランクは25%、約175名で、目標を着実に達成した方です。

残り55%のB以下はインセンティブなしです。受給者は全体の45%、約315名です。

3. シミュレーション結果

3つのシナリオを用意しています。

初年度はシナリオ1の保守的な運用を推奨します。増収が確認される前の段階で、Sランク年40万円、Aランク年20万円、インセンティブ総額6,000万円です。

経営改善により1.5億円の増収を達成した場合はシナリオ2に移行します。Sランク年60万円、Aランク年30万円、インセンティブ総額は8,850万円です。増収の59%を職員に還元しつつ、粗利益1.8億円を確保します。

経営改善が大きく進み3億円の増収を達成した場合はシナリオ3です。Sランク年100万円、Aランク年40万円、インセンティブ総額1億2,180万円です。粗利益3億円を確保した上で、頑張った職員に大きく報いることができます。

4. Sランクの具体的なイメージ

Sランクの基準は高く設定します。具体的には、整形外科の医師が紹介元への訪問を月5件以上行い紹介件数を前年比20%以上回復させた場合。あるいは病棟看護師長が退院支援フローを再設計し平均在院日数を0.5日短縮させた場合。医事課スタッフが施設基準管理システムの運用を主導し算定漏れゼロを達成した場合。このように、自分の職務を超えて組織全体に価値をもたらした方にのみ付与します。

5. 導入スケジュール

令和8年度の第1四半期に制度設計を確定し、KPIインセンティブを先行導入します。第2四半期に人事評価基準を策定し管理職への研修を行います。第3四半期に中間評価、第4四半期に年度末評価とインセンティブ支給です。粗利益が確定してから支給額を最終決定するため、経営リスクは限定的です。

まとめ（2分）

最後にまとめます。

法人全体は大森再開発という100年に一度の大型投資の真っ只中にあり、令和7年度は10.7億円の赤字予算です。資産のストックには余裕がありますが、手許資金は3年で6割減少する見通しです。

この環境下で大橋病院は、3病院中唯一の粗利益改善を達成し、法人を支える重要な柱です。今後も外来患者数の回復、ダヴィンチ拡大、改定効果の取り込み、医療経費の抑制という4つの施策で年間1.6億から4.5億円の収益改善を目指します。

加えて、業績連動型のインセンティブ制度を導入し、増収の成果を職員に還元する仕組みを構築します。初年度は6,000万円規模でテスト導入し、増収が確認されたら段階的に拡大します。Sランクの職員には年60万から100万円のインセンティブで大きく報いることで、経営改善と人材投資の好循環を目指します。

以上です。ご質問があればお受けいたします。

参考資料一覧

No.	資料名	主な分析テーマ
1	令和7年度予算の概要	法人全体の収支概要
2	令和7年度事業活動収支予算書	詳細な収入・支出項目
3	令和7年度資金収支予算書	資金の流れ・繰越支払資金
4	法人全体収支計画（新中期R7-R9）	3年間の収支・投資・CF計画
5	令和6年度貸借対照表	資産・負債・純資産の実態
6	令和7年度上期事業運営状況	上期の実績と進捗
7	学校法人東邦大学 令和7年度事業計画	年度の事業方針
8	組織目標（令和8年度）各所属	大橋病院の組織目標と具体策

詳細資料

成果物	格納先
法人経営環境分析レポート	analysis/planning/report/
大橋病院経営戦略提言書	analysis/planning/report/
インセンティブ制度シミュレーション	analysis/planning/report/
想定Q&A集（15問）	analysis/planning/qa/
インサイトレポート（5視点統合分析）	analysis/planning/insights/